

ЧЕК-ЛИСТ

Ургентный осмотр: лидер и адьютор

Распределение работы в бригаде из двух человек на всех этапах осмотра пациента в критическом состоянии

Порядок построен по протоколу ургентного осмотра: подготовка до прибытия, первичная оценка, последовательность ABCDE, действия после осмотра. Для каждого этапа указано, что делает лидер и что одновременно с ним делает адьютор, а для дыхательных путей, дыхания и кровообращения — как распределение меняется при выявленных нарушениях.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 27 сентября 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Роли

Роль	Кто	Что делает
Лидер	Ответственный по бригаде либо наиболее опытный сотрудник	Проводит осмотр пациента, собирает анамнез, руководит оказанием помощи, принимает тактические решения на месте вызова, выполняет манипуляции по устранению жизнеугрожающих состояний
Адьютор	Помощник: фельдшер или медицинская сестра	Выполняет манипуляции по указанию лидера, обеспечивает первичную респираторную поддержку (масочная оксигенотерапия, ручная вентиляция), выполняет измерения и обеспечивает сосудистый доступ

Роли распределяются **до прибытия на место вызова**, а не у пациента. Манипуляции по устранению жизнеугрожающих состояний — остановка кровотечения, устранение асфиксии, пункция плевральной полости — выполняет любой из двоих: лидер самостоятельно либо адьютор по указанию лидера.

Каждое назначение адресуется конкретному человеку, исполнение подтверждается голосом, результат докладывается лидеру числом: «сатурация 82», «давление 70 на 40», «глюкоза 3,1». Формулировка «сделано» без результата не заменяет доклада.

Этап 0. До прибытия на вызов

Лидер	Адьютор
Распределяет роли и проводит краткий инструктаж по порядку действий на вызове	Слушает инструктаж, уточняет, что берёт на себя
Просматривает данные ЕМИАС и личного кабинета ФОМС, данные опроса диспетчера, наличие повторных вызовов к этому пациенту	Готовит оборудование по поводу к вызову, определяет, кто что несёт
По возможности связывается с вызывающим для уточнения состояния	Включает монитор, готовит кислородную магистраль и раствор для инфузии, размещает оборудование в салоне так, чтобы выйти с ним без задержки

Проверка личной и инфекционной безопасности — оба: верхняя одежда застёгнута, карманы закрыты, волосы убраны, часы и браслеты сняты; перчатки и маски у обоих; защитные очки или экран обязательны при работе с дыхательными путями.

Повод к вызову	Что берётся дополнительно к общепрофильной укладке, базовому ургентному набору и абонентскому комплексу
«Без сознания», «нарушение сознания с угрозой жизни», «нарушение дыхания с угрозой жизни», «не дышит», «хрипит», «посинел», «подавился, не дышит»	Реанимационный набор по возрасту, источник кислорода, дефибриллятор
Вызов «на себя» с реанимационным диагнозом	То же и аппарат искусственной вентиляции лёгких

Этап 1. Прибытие и первичная оценка

Лидер	Адьютор
Оценивает безопасность места вызова — оба, вслух, до подхода к пациенту	Оценивает безопасность места вызова
Оценка «с порога»: положение пациента, общий вид, целенаправленные движения, цвет кожи, приблизительный возраст, пол, рост и вес, доступность осмотру, видимые повреждения	Размещает оборудование и монитор у пациента со стороны, свободной для лидера
«Что случилось?» — первый вопрос окружающим	Готовит пульсоксиметр и глюкометр к работе

Этап 2. Сознание

Оценка уровня сознания выполняется обоими: лидер обращается к пациенту, адьютор наблюдает за дыханием и движениями.

Шкала AVPU	Что означает
A (alert)	В сознании, активен, сознание ясное
V (verbal)	Реагирует на голос: оглушение, сопор
P (pain)	Реагирует на боль: сопор, неглубокая кома
U (unresponsive)	Не реагирует: глубокая кома

Отсутствие сознания и отсутствие дыхания — немедленное начало сердечно-лёгочной реанимации; осмотр по ABCDE прекращается.

А. Дыхательные пути

При ясном сознании и активной речи проходимость дыхательных путей сомнений не вызывает, и оценка не требуется. При сниженном сознании оценка проходимости и оценка дыхания проводятся одновременно.

Ситуация	Лидер	Адьютор
Проходимы	Оценка проходимости ВДП, переход к В	Наблюдение, подготовка оборудования к следующему этапу
Храп	Оценка проходимости → выдвижение нижней челюсти → повторная оценка проходимости	Установка воздуховода
Булькающее дыхание	Оценка проходимости → повторная оценка проходимости	Санация верхних дыхательных путей
Стридор	Оценка проходимости → решение о протекции дыхательных путей → восстановление проходимости при жизнеугрожающем состоянии	Санация верхних дыхательных путей → вентиляция дыхательным мешком
Апноэ	Начало сердечно-лёгочной реанимации	Компрессии либо вентиляция по указанию лидера

Протезирование дыхательных путей выполняется последовательно и только при неэффективности предыдущего метода: воздуховод, надгортанное устройство или интубация трахеи, коникотомия.

В. Дыхание

Последовательность лидера одинакова во всех ситуациях: **эффективность дыхания → симметричность трахеи и состояние вен шеи → осмотр грудной клетки → аускультация в шести точках → перкуссия в шести точках**. Меняется только работа адьютора.

Ситуация	Адьютор
Дыхание эффективное	Пульсоксиметрия с началом осмотра грудной клетки
Дыхательная недостаточность I–II степени	Пульсоксиметрия → ингаляция кислорода
Дыхательная недостаточность III–IV степени или брадипноэ	Пульсоксиметрия → вентиляция дыхательным мешком, подключённым к источнику кислорода
Напряжённый пневмоторакс	Пульсоксиметрия → ингаляция кислорода → пункция плевральной полости выполняется лидером или адьютором по указанию лидера → продолжение ингаляции кислорода; лидер повторно проводит аускультацию и перкуссию

Оценка эффективности дыхания — правило «вижу — слышу — ощущаю» за 10 секунд при открытых дыхательных путях: экскурсия грудной клетки, звуки изо рта, движение воздуха. Число вдохов за 10 секунд умножается на 6.

Частота дыхания	Трактовка
8–32 в минуту	Дыхание эффективное
Менее 8 либо более 32 в минуту	Дыхание неэффективное: требуется респираторная поддержка немедленно

Точки аускультации и перкуссии: второе-третье межреберье по средней ключичной линии, пятое-шестое по передней подмышечной, шестое-седьмое по задней подмышечной — симметрично с двух сторон.

С. Кровообращение

Последовательность лидера: **пульс на сонной и лучевой артерии одновременно → сравнительная оценка пульса на лучевых артериях → симптом белого пятна → аускультация тонов сердца с оценкой дефицита пульса → регистрация ЭКГ в 12 отведениях и сбор анамнеза**. Распределение остального зависит от того, кто регистрирует ЭКГ.

Вариант	Лидер	Адьютор
Первый	Пульс, симметричность, белое пятно, тоны сердца; затем регистрация ЭКГ и сбор анамнеза	Измерение артериального давления после оценки симметричности пульса; сосудистый доступ во время регистрации ЭКГ

Вариант	Лидер	Адьютор
Второй	Пульс, симметричность, белое пятно, тоны сердца; измерение артериального давления; сбор анамнеза	Регистрация ЭКГ в 12 отведениях и обеспечение сосудистого доступа

Артериальное давление измеряется **только после** оценки симметричности пульса: раздувание манжеты искажает результат сравнительной оценки. При выявленной асимметрии давление измеряется на обеих руках.

Находка	Ориентировочное значение
Пульс есть на лучевой артерии	Систолическое давление более 80 мм рт. ст.
Пульс только на сонной артерии	Систолическое давление более 40 мм рт. ст.
Время капиллярного наполнения до 3 с	Норма
Время капиллярного наполнения более 3 с	Циркуляторные нарушения

При признаках нарушения гемодинамики инфузия кристаллоидами начинается сразу после обеспечения доступа, не дожидаясь окончания осмотра.

D. Неврологический статус

Лидер	Адьютор
Оценка по шкале комы Глазго (учитывается лучший ответ, полученный за весь осмотр)	Глюкометрия
Зрачки: размер, симметричность, прямая и содружественная реакция на свет	Подготовка препаратов по указанию лидера
Моторный дефицит: мышечный тонус попарно на верхних и нижних конечностях, мышечная сила при достаточном уровне сознания	Терапия по показаниям по указанию лидера
Менингеальные симптомы: ригидность затылочных мышц сразу после оценки зрачков, симптомы Кернига и Брудзинского вместе с оценкой тонуса	

Глюкометрия обязательна при любом нарушении сознания.

E. Общий осмотр

Лидер	Адьютор
Осмотр и пальпация живота в четырёх точках: симметричность, участие в дыхании, повреждения, боль и напряжение	Термометрия — начинается в начале этапа, поскольку требует времени; при подозрении на гипотермию ректально либо в паховой складке

Лидер	Адьютор
Сравнительная пальпация пульса на бедренных артериях: симметричность, наполнение	
Осмотр конечностей: кожа, повреждения, отёки, варикозно расширенные вены	
Кожа и слизистые на участках, не осмотренных ранее: цвет, влажность, сыпь, пролежни, рубцы, повреждения	
Осмотр спины в устойчивом боковом положении	Помощь в повороте пациента
Ректальное исследование по показаниям: признаки шока в рамках поиска источника кровотечения	Утилизация отходов, оформление документации

После осмотра

Действие	Кто	Содержание
Повторный осмотр	Лидер	Только те области и системы, где выявлены отклонения или требуется уточнение
Мониторинг	Адьютор	ЭКГ-мониторинг, артериальное давление, сатурация, капнометрия; при критическом состоянии регистрация ЭКГ на бумажном носителе каждые 5 минут
Терапия	Лидер назначает, адьютор выполняет	По приказу ДЗМ Москвы № 535 от 18.05.2023 в соответствии с выявленным состоянием
Дополнительные исследования	По решению лидера	Ультразвуковое исследование, капнометрия, экспресс-тесты, анализ крови — при показаниях и технической возможности
Решение о маршруте	Лидер	Медицинская эвакуация, вызов бригады «на себя», дистанционный консилиум
Эвакуация	Оба	Непрерывный мониторинг и продолжение терапии в пути

Положения, в которых теряются баллы и время

- Артериальное давление измерено до сравнительной оценки пульса — сравнительная оценка обесценена.
- Перкуссия пропущена: по протоколу она обязательна, в шести точках, симметрично.
- Термометрия оставлена на конец осмотра — её результат не успевает появиться.
- Глюкометрия не выполнена при нарушении сознания.
- После вмешательства не проведена повторная оценка того же параметра: выдвинули челюсть — заново оценили проходимость, выполнили пункцию — заново выслушали и перкутировали.
- Оценка по шкале комы Глазго выставлена по одному моменту, а не по лучшему ответу за весь осмотр.
- Роли не распределены до входа к пациенту, и оба выполняют одно и то же.
- Результат доложен без числа.

Источники

- Протокол ургентного осмотра: порядок проведения общетерапевтического осмотра пациента в критическом состоянии бригадами скорой медицинской помощи. ГБУЗ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова» Департамента здравоохранения города Москвы; Трофимова И. А., 2025–2026 — распределение ролей, последовательность этапов, схемы работы в команде, пороги эффективности дыхания, ориентиры систолического давления по пульсу, время капиллярного наполнения.
- Приказ Департамента здравоохранения города Москвы № 535 от 18.05.2023 «Об утверждении Алгоритмов оказания скорой и неотложной медицинской помощи» — объём терапии по выявленному состоянию.

Выходные данные

Материал: «Ургентный осмотр: лидер и адъютант». Версия 1.0. Чек-лист сопровождается материалом «Протокол ургентного осмотра: теория», где разобраны обоснование каждого шага и шкалы.

Серия: «Крещение поворотом» — материалы догоспитальной практики.

Лицензия: текст — Creative Commons «С указанием авторства — Некоммерческая — С сохранением условий» 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0).

Оговорка. Материал носит справочный характер, не является нормативным документом и не заменяет действующие приказы и распоряжения службы. Ответственность за клинические решения несёт медицинский работник, а не автор материала.

Нашли ошибку? Сообщить можно через раздел Issues репозитория проекта; исправление выходит новой версией, а изменение фиксируется в журнале изменений.